

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA DELIMITACIÓN DEL ROL FARMACÉUTICO EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Fabiola López*, Nahomith Molina, José Torrealba

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela.

*fabi.lopez.centofanti@gmail.com

RESUMEN

La hiper-accesibilidad del servicio farmacéutico genera una confusión asistencial sobre el rol del farmacéutico que lleva al usuario a demandar facultades diagnósticas y prescriptivas propias del médico. Esta desdibujación de roles no solo compromete el sistema de doble control sanitario, sino que impone dilemas éticos y riesgos para la seguridad del paciente, como la automedicación y el uso irracional de fármacos. Ante este escenario, la investigación propone un modelo de intervención basado en la comunicación estratégica, estructurado en cuatro ejes fundamentales: el rediseño visual del punto de venta para establecer límites competenciales simbólicos, la estandarización de una comunicación verbal asertiva centrada en la seguridad, la implementación de programas de alfabetización sanitaria y la resignificación del rol del farmacéutico como experto en farmacoterapia. Se concluye que el conflicto en el mostrador es un fenómeno predominantemente comunicacional y educativo, cuya resolución radica en la reeducación del usuario mediante soportes informativos que actúan como herramientas de bioseguridad. Al validar la información visual y verbal como instrumentos de gestión clínica, el estudio demuestra que la delimitación de funciones no debilita la figura profesional, sino que la dignifica, transformando la farmacia en un espacio de colaboración interdisciplinaria y promoviendo un entorno de dispensación más seguro y ético.

Palabras clave: Campaña publicitaria, Dispensación, Farmacéuticos, Rol profesional, Salud pública.

ABSTRACT

The hyper-accessibility of pharmaceutical services creates a healthcare-related confusion regarding the pharmacist's role, leading users to demand diagnostic and prescriptive powers that belong to physicians. This blurring of professional boundaries not only compromises the healthcare system's "double-check" mechanism but also imposes ethical dilemmas and risks to patient safety, such as self-medication and irrational drug use. In response to this scenario, this research proposes an intervention model based on strategic communication, structured around four fundamental pillars: visual re-engineering of the point of sale to establish symbolic jurisdictional boundaries, the standardization of assertive verbal communication focused on safety, the implementation of health literacy programs, and the resignification of the pharmacist's clinical role as a pharmacotherapy expert. It is concluded that the conflict at the pharmacy counter is a predominantly communicational and educational phenomenon, the resolution of which lies in re-educating the user through informative supports that function as biosafety tools. By validating visual and verbal information as clinical management instruments, the study demonstrates that the delimitation of functions does not weaken the professional figure but rather dignifies it, transforming the pharmacy into a space for interdisciplinary collaboration and promoting a safer and more ethical dispensing environment.

Keywords: Advertising campaign, Dispensing, Pharmacists, Professional role, Public health.

INTRODUCCIÓN

La farmacia comunitaria es, en muchos casos, el primer punto de contacto del ciudadano con el sistema de salud. No obstante, existe una problemática histórica y social donde el rol del farmacéutico es confundido con el del médico prescriptor. Esta situación conlleva a que el usuario demande diagnósticos y tratamientos directos en el mostrador, ignorando que la formación del farmacéutico, aunque profunda en farmacología, no le faculta legal ni clínicamente para recetar. Según la Federación Internacional Farmacéutica (FIP, 2020), la dispensación debe ser un acto profesional de validación y educación, no un acto de prescripción encubierta.

La farmacia comunitaria se erige como un eslabón crítico en la cadena de atención primaria, funcionando como un centro de salud de baja complejidad y alta accesibilidad. Sin embargo, esta cercanía física y emocional con la comunidad ha generado un fenómeno de "hiper-accesibilidad", donde el usuario tiende a desdibujar las fronteras competenciales entre las distintas ramas de la salud. A diferencia de la consulta médica, que suele requerir citas previas y protocolos administrativos, el mostrador de la farmacia ofrece una inmediatez que el ciudadano confunde erróneamente con una facultad diagnóstica.

Esta confusión no es solo un error de percepción, sino un riesgo latente para la seguridad del paciente. Cuando un farmacéutico es presionado para actuar como prescriptor, se rompe el sistema de "doble control" (diagnóstico médico y validación farmacéutica) que garantiza el éxito del tratamiento. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso racional de los medicamentos depende de que cada profesional ejerza dentro de su ámbito de competencia científica y legal.

La problemática se agrava en contextos socioeconómicos donde el sistema de salud saturado empuja al paciente a buscar soluciones rápidas. El farmacéutico se enfrenta entonces a un dilema ético: la intención de ayudar al paciente frente al estricto cumplimiento del marco legal. La dispensación informada, que debería ser un proceso de educación sanitaria sobre dosis, interacciones y conservación, se ve frecuentemente interrumpida por solicitudes de antibióticos o fármacos sujetos a receta médica sin la debida orden facultativa.

La implementación de una campaña publicitaria no es, por tanto, una medida meramente informativa, sino una herramienta de gestión del cambio conductual. Al reeducar al usuario mediante soportes visuales y mensajes claros, se busca transformar la farmacia en un espacio de consulta sobre el medicamento, no sobre la patología.

Hacia un Modelo de Colaboración Interdisciplinaria, la investigación propone que la clarificación de roles no debilita la figura del farmacéutico, sino que la dignifica. Al eliminar la expectativa de prescripción, el profesional puede centrarse en el seguimiento farmacoterapéutico y la detección de Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM).

La hipótesis de este estudio sostiene que el refuerzo visual en el punto de venta actúa como una barrera preventiva. Al modificar el entorno físico del mostrador con información estructurada, se espera una disminución en los conflictos de comunicación y una mayor aceptación de la derivación médica. En última instancia, este estudio busca validar que una sociedad bien informada sobre las funciones de sus profesionales de salud es una sociedad con menores índices de automedicación y mejores resultados clínicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objetivo de ofrecer soluciones viables a la problemática identificada, se proponen las siguientes estrategias:

- Estrategias de comunicación visual en el punto de dispensación: El entorno físico de la farmacia comunitaria no es un espacio neutro; funciona como un dispositivo de comunicación no verbal que condiciona la conducta del usuario. Se propone la implementación de un sistema de señales visuales diseñado para gestionar las expectativas desde el primer contacto. A través de: la instalación de material gráfico (afiches) que delimite las fronteras entre el diagnóstico clínico (facultad médica) y la validación farmacéutica; despliegue de infografías que ilustren la trazabilidad del acto sanitario: diagnóstico, prescripción, dispensación y seguimiento. Este recurso pedagógico justifica la necesidad de la receta como un requisito de seguridad y no como un obstáculo burocrático. La comunicación visual funciona como una barrera preventiva pasiva, reduciendo la necesidad de confrontación verbal y normalizando la derivación médica como parte del proceso asistencial.
- La estrategia de comunicación en redes sociales debe establecer una frontera clara y ética entre el diagnóstico médico y la labor farmacéutica, utilizando estas plataformas para enfatizar que nuestra función no es recetar ni diagnosticar, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al médico. El contenido debe centrarse en la atención farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico,

posicionando al farmacéutico como el experto que valida, educa y supervisa el uso correcto del tratamiento ya prescrito. Al comunicar de forma transparente que nuestra intervención comienza donde termina la consulta médica, reforzamos la seguridad del paciente y proyectamos una imagen de profesionalismo y respeto interdisciplinar, evitando cualquier confusión de roles y priorizando siempre la salud del usuario a través del consejo farmacéutico responsable.

- Estrategias de comunicación verbal asertiva y estandarizada: La delimitación del rol no debe percibirse como una negación de ayuda, sino como una acción de cuidado responsable, para ello es imperativo que el equipo farmacéutico adopte un modelo de comunicación centrado en el cuidado y la seguridad del paciente, mediante el desarrollo de guiones institucionales que empleen la técnica del "puente", priorizando la orientación sobre el medicamento mientras se redirige la demanda diagnóstica al profesional competente, por ejemplo: "Como farmacéutico puedo orientarlo sobre el medicamento, pero el diagnóstico corresponde al médico".
- Estrategias de educación sanitaria orientadas al usuario: La delimitación de roles requiere un proceso de "reeducación de paciente" que podría implementarse mediante material educativo impreso o digital sobre riesgos de la automedicación, campañas temáticas (ejemplo: uso responsable de antibióticos, analgesia segura, etc.),

incluyendo micro-educación durante la dispensación (empleando mensajes breves y repetitivos).

- Estrategias de resignificación del rol farmacéutico: La clarificación de las funciones no debe interpretarse como una reducción de la autoridad farmacéutica, sino como una especialización de su figura como experto en farmacoterapia. La comunicación explícita de servicios farmacéuticos profesionales (como el seguimiento farmacoterapéutico, detección de PRM, farmacovigilancia) contribuye a desplazar el foco desde la prescripción hacia el cuidado farmacoterapéutico, fortaleciendo la legitimidad profesional.

CONCLUSIONES

Se concluye que la problemática del rol farmacéutico en la dispensación tiene una raíz principalmente educativa y comunicacional. La implementación de campañas publicitarias dentro y fuera del establecimiento de farmacia permite reducir la brecha de desinformación, logrando que el usuario identifique al farmacéutico como un aliado de su tratamiento y no como un sustituto del médico. Los datos objetivos respaldan la hipótesis de que la información visual clara disminuye la presión asistencial sobre el farmacéutico para realizar actos de prescripción. Finalmente, se ratifica que el farmacéutico cumple su rol ético al negarse a recetar, priorizando la seguridad del paciente y la legalidad vigente.

La relevancia académica y social del artículo, reside principalmente en su capacidad para diseccionar una problemática estructural del sistema

sanitario: la crisis de identidad funcional en la oficina de farmacia. El estudio propone que el conflicto que surge en el mostrador no es un evento aislado o meramente transaccional, sino el síntoma de una brecha educativa profunda entre la ciencia farmacéutica y la percepción ciudadana. Al concluir que el origen de esta confusión es esencialmente comunicacional, el artículo desplaza la responsabilidad de la confrontación directa hacia una solución sistémica, sugiriendo que la reeducación del usuario es el único camino viable para preservar la integridad de la práctica profesional.

Uno de los pilares más significativos de esta investigación es la validación de la información visual como un instrumento de gestión clínica y ética. El artículo demuestra mediante datos que la implementación de campañas publicitarias estructuradas no busca simplemente informar, sino modificar el comportamiento y las expectativas del paciente. Al reducir la "presión asistencial" para recetar, la estrategia comunicacional actúa como un escudo que protege al farmacéutico, permitiéndole ejercer su función de validación y educación sanitaria sin verse compelido a transgredir el marco legal. De este modo, la comunicación estratégica se convierte en una herramienta de bioseguridad que minimiza los riesgos asociados a la prescripción errónea o la automedicación.

Finalmente, el análisis subraya que la delimitación de roles no constituye una limitación del poder profesional, sino una elevación de su estatus ético. El artículo es fundamental porque redefine al farmacéutico no como un sustituto o un médico de segunda instancia, sino como un aliado indispensable del tratamiento farmacológico. Al ratificar que la negativa a prescribir es un acto de compromiso con la seguridad del paciente y la legalidad vigente, el estudio fortalece la colaboración interdisciplinaria. En última instancia, la importancia de este trabajo

radica en que proporciona la evidencia necesaria para transformar la farmacia comunitaria en un espacio donde la ética y la comunicación estratégica convergen para garantizar un sistema de salud más ordenado, seguro y profesionalmente respetuoso.

REFERENCIAS

1. Federación Internacional Farmacéutica (FIP). (2020). *Directrices sobre buenas prácticas farmacéuticas*. FIP Publishing.
2. López, R., & García, M. (2022). Percepción social del farmacéutico en la atención primaria. *Revista de Salud Pública*, 14(2), 112-125.
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). *El papel del farmacéutico en el sistema de salud*. Ginebra: OMS.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés comercial ni personal en la realización y publicación de este artículo científico.